جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هدي محمد رمضان احمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المعادي **العنوان :** =
رقم البطاقة : 26903140101425 **رقم التليفون :** 01158226240 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-03-1969 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هدي محمد رمضان احمد
National ID: 26903140101425

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

هدى
محمد رمضان احمد
٧٥ ش الترعه
المعادى - القاهره

٢٥ ١٤ ٠١ ٠ ٣١٤ ٠ ٢٦٩

KY3240373

٠١١٠٢٨٦٨٤٧

٢٥١٤٠١٠١٠-٢٦٩٠٣١٤٠١٠ ٢٠٢٥/٠١

حاصله على دبلوم تجاره

انثى مسلمة متزوجة

صابر صبحى السيد عبدالمولى

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٧/٠٣

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hoda Mohamed Ramadan Ahmed	Date : 27/06/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1825/2021	Pat. ID: 14308

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

- Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- LOQ Operative bed thick branching scarring with related parenchymal distortion. Ill-defined deeply hypoechoic area is seen related to the lateral portion of the scar.
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing LOQ operative bed thick scarring with related parenchymal distortion and focal palpable hypoechoic area; ? post-operative changes, for better assessment by CESM (BIRADS 3)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Peter Nashat

27/06/2022 12:57 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Name: هدى محمد رمضان احمد **MR. :** 8949	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is receiving ARAMIDEX with supportive therapy and has been cleared for ZOMETA; no dental extractions are required. The plan includes monitoring for potential complications and continuing the current regimen.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Name: هدى محمد رمضان Age: 52 years.
Clinical data: Left breast mass
Specimen type: WLE + Axillary Clearance
Date (Received):21 /6/2021. Date(reported): 4 /7/2021
Lab. Number:1308 / 21 Hospital Number:

Gross Examination:

- Procedure: WLE + Axillary Clearance
- Localization: Left breast UIQ mass
- Tumor extent
  - Number: One
  - Size: 1.9 x 1.3 x 1cm
  - Skin involvement: No
- Distance from margins: 3 cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 4 LNs up to 2 cm

Microscopic examination:

Histopathological examination of sections prepared from the tumor mass reveals an infiltrating malignant epithelial growth made up of groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II] Ductal carcinoma in situ (less than 10%) could be detected. Negative Lymphocytic infiltration (0/4 LNs). No Lymphovascular invasion . The surgical margins are free.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Diagnosis:

Left breast mass ; WLE + Axillary Clearance :

Invasive duct carcinoma, Grade II.

Negative Lymphocytic infiltration (0/4 LNs) . No Lymphovascular invasion. Free margins.

Stage : pT1c , pN0, pMx.

Prof. Dr. Lubna Omar

Dr. Samah Sayed

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hoda Mohamed Ramadan Ahmed	Date : 28/07/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 53 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 14308

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

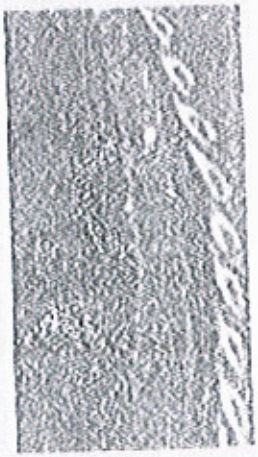
Known case of breast cancer underwent left BCS.

I Chest:-



- Right upper lung lobe apical segment nodular density measures 6 mm.
- Lingular sgement atelectasis.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:



- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal appearance of the kidneys, pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- D3 sclerotic bony lesion measuring 7 mm.

Opinion:

- **Rigth upper lung lobe tiny nodule likely non specific for follow up.**
- **No hepatic metastatic deposits.**
- **D3 sclerotic bony lesion for bone scan correlation.**

Dr. Aya Daebes, MSC

Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]